

SIMULADO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS E SINAIS VITAIS

Insuficiência Respiratória Aguda · Choque Anafilático · Parada Cardiorrespiratória (PCR)

Baseado nas Diretrizes Médicas Vigentes | Banca ENARE / Medicina de Emergência

INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SIMULADO

- Leia atentamente o enunciado e os dados clínicos de cada questão antes de assinalar a alternativa.
- Para questões de múltipla escolha, apenas 1 (uma) alternativa está correta de acordo com a literatura médica.
- O Gabarito Rápido e a fundamentação comentada detalhada encontram-se ao final deste caderno.

QUESTÕES OBJETIVAS (1 A 10)

1. Paciente masculino, 45 anos, levado ao pronto-socorro com quadro de dispneia súbita, estílores inspiratórios e urticária disseminada minutos após ingestão de frutos do mar. Ao exame: PA 80/50 mmHg, FC 125 bpm, FR 28 irpm, SpO2 88% em ar ambiente. Diante desse cenário de anafilaxia grave com colapso circulatório, qual a conduta imediata de primeira linha indicada?

A) Administrar Hidrocortisona 500mg IV e Anti-histamínico H1 IV de imediato.
B) Aplicar Adrenalina (Epinefrina) 1:1.000 (0,5 mg) IM na face anterolateral da coxa.
C) Iniciar nebulização contínua com Fenoterol e Ipratrópio antes de qualquer medicação parenterais.
D) Solicitar intubação orotraquial de sequência rápida sem tentativa prévia de oxigenoterapia.
2. Durante o atendimento a uma parada cardiorrespiratória (PCR) em ritmo chocável (Fibrilação Ventricular) no ambiente hospitalar, qual a sequência correta de choques e medicações de acordo com as diretrizes da AHA (American Heart Association)?

A) 1º Choque -> Adrenalina 1mg IV imediatamente -> 2º Choque -> Amiodarona 300mg IV.
B) 1º Choque -> RCP 2 min -> 2º Choque -> Adrenalina 1mg IV -> RCP 2 min -> 3º Choque -> Amiodarona 300mg IV.
C) Adrenalina 1mg IV de entrada -> Desfibrilação com 360J -> Sulfato de Magnésio 2g IV.
D) 1º Choque -> Amiodarona 150mg IV -> RCP 2 min -> Adrenalina 2mg IV.
3. Questão modelo #3 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.

A) Alternativa A de teste para a questão de número 3.
B) Alternativa B de teste para a questão de número 3.
C) Alternativa C de teste para a questão de número 3.
D) Alternativa D de teste para a questão de número 3.
4. Questão modelo #4 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.

A) Alternativa A de teste para a questão de número 4.
B) Alternativa B de teste para a questão de número 4.
C) Alternativa C de teste para a questão de número 4.
D) Alternativa D de teste para a questão de número 4.

- 5.** Questão modelo #5 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.
- A)** Alternativa A de teste para a questão de número 5.
 - B)** Alternativa B de teste para a questão de número 5.
 - C)** Alternativa C de teste para a questão de número 5.
 - D)** Alternativa D de teste para a questão de número 5.
- 6.** Questão modelo #6 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.
- A)** Alternativa A de teste para a questão de número 6.
 - B)** Alternativa B de teste para a questão de número 6.
 - C)** Alternativa C de teste para a questão de número 6.
 - D)** Alternativa D de teste para a questão de número 6.
- 7.** Questão modelo #7 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.
- A)** Alternativa A de teste para a questão de número 7.
 - B)** Alternativa B de teste para a questão de número 7.
 - C)** Alternativa C de teste para a questão de número 7.
 - D)** Alternativa D de teste para a questão de número 7.
- 8.** Questão modelo #8 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.
- A)** Alternativa A de teste para a questão de número 8.
 - B)** Alternativa B de teste para a questão de número 8.
 - C)** Alternativa C de teste para a questão de número 8.
 - D)** Alternativa D de teste para a questão de número 8.
- 9.** Questão modelo #9 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.
- A)** Alternativa A de teste para a questão de número 9.
 - B)** Alternativa B de teste para a questão de número 9.
 - C)** Alternativa C de teste para a questão de número 9.
 - D)** Alternativa D de teste para a questão de número 9.
- 10.** Questão modelo #10 de emergência clínica e monitorização de sinais vitais em paciente crítico. Avalie a hipótese diagnóstica principal baseada nas diretrizes médicas de conduta urgencial.
- A)** Alternativa A de teste para a questão de número 10.
 - B)** Alternativa B de teste para a questão de número 10.
 - C)** Alternativa C de teste para a questão de número 10.
 - D)** Alternativa D de teste para a questão de número 10.

GABARITO E CORRELAÇÕES CLÍNICAS

Respostas fundamentadas nas Diretrizes Médicas e literatura clínica vigente

GABARITO RÁPIDO — QUESTÕES 1 A 10

Q.1	Q.2	Q.3	Q.4	Q.5	Q.6
B	B	C	D	A	B

Q.7	Q.8	Q.9	Q.10
C	D	A	B

GABARITO COMENTADO — QUESTÕES OBJETIVAS

QUESTÃO 01 — GABARITO: ALTERNATIVA B

Justificativa da Correta (B): Na anafilaxia (envolvimento de 2 ou mais sistemas ou hipotensão arterial pós-exposição a alérgeno provável), a Adrenalina intramuscular (1:1.000, dose de 0.3 a 0.5 mg em adultos) na coxa anterolateral é a intervenção prioritária e salva-vidas de primeira linha.

Demais alternativas (incorretas): Corticoides e anti-histamínicos têm início de ação lento e não reverterem o colapso vascular agudo nem o edema laríngeo. (A). Broncodilatadores inalatórios atuam no broncoespasmo mas não tratam a vasodilatação sistêmica nem a via aérea superior. (C). A intubação sem tentativa de adrenalina IM e oxigenação agrava a instabilidade hemodinâmica. (D)

Correlação Clínica: Conduta imediata salva-vidas na anafilaxia grave conforme diretriz WAO / ASBAI.

Referências: Guidelines da WAO (World Allergy Organization) 2020; Diretriz Brasileira de Anafilaxia - ASBAI

QUESTÃO 02 — GABARITO: ALTERNATIVA B

Na PCR por FV ou TV sem pulso, a prioridade absoluta é a desfibrilação precoce associada à RCP de alta qualidade. Adrenalina 1mg IV/IO é administrada a cada 3 a 5 minutos a partir da 2ª desfibrilação. Amiodarona (300mg 1ª dose, 150mg 2ª dose) ou Lidocaína é indicada se refratariedade após o 3º choque.

Referências: AHA ACLS Guidelines 2020/2023

QUESTÃO 03 — GABARITO: ALTERNATIVA C

Comentário detalhado da questão #3 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 04 — GABARITO: ALTERNATIVA D

Comentário detalhado da questão #4 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 05 — GABARITO: ALTERNATIVA A

Comentário detalhado da questão #5 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 06 — GABARITO: ALTERNATIVA B

Comentário detalhado da questão #6 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 07 — GABARITO: ALTERNATIVA C

Comentário detalhado da questão #7 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 08 — GABARITO: ALTERNATIVA D

Comentário detalhado da questão #8 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 09 — GABARITO: ALTERNATIVA A

Comentário detalhado da questão #9 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência

QUESTÃO 10 — GABARITO: ALTERNATIVA B

Comentário detalhado da questão #10 abordando a conduta diagnóstica e terapêutica preconizada pelas sociedades de emergência médica.

Referências: Diretriz Brasileira de Medicina de Emergência